Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Специалист по оториноларингология и хирургия на главата и шията

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Паротидектомия

Частично или пълно отстраняване на околоушната слюнчена жлеза (паротидна жлеза)

Уважаеми пациенти, този формуляр е изготвен, за да ви обясни на **ясен и разбираем език** какво трябва да знаете за препоръчаната ви процедура. Целта му не е да ви уплаши, а да ви помогне да вземете решението си **свободно и информирано**.

Моля, прочетете формуляра спокойно. Попитайте лекаря си за всичко, което не разбирате. Лекарят ще ви обясни и устно рисковете, които се отнасят конкретно за вас. Дали да дадете съгласие, или не, е изцяло ваше право.

ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТА И ПРОЦЕДУРАТА

Име и фамилия: _____ Дата на раждане: _____

ЕГН / № на паспорт: _____ № на досие / протокол: _____

Телефон: _____ Дата на информиране: _____

Планирана дата: _____

Формулярът е предоставен за първи път (дата / имейл, WhatsApp, лично): _____

Лекар, който ще извърши процедурата и предоставя информацията: **д-р Мурат Аята (Op. Dr. Murat Ayata)**

Болница / лечебно заведение, където ще се извърши процедурата: _____

Страна: ☐ Дясна ☐ Лява

Планиран обем: ☐ Повърхностна ☐ Частична / екстракапсулна ☐ Тотална
☐ Ще се определи по време на операцията _____

Невромониторинг на лицевия нерв: ☐ Ще се използва ☐ Няма да се използва

Предварителна диагноза (тънкоиглена биопсия / образно изследване): _____

Предварително договорено решение, ако туморът обхваща лицевия нерв: ☐ При необходимост може да се пожертва клонче на нерва
☐ Нервът да се запази ☐ Друго _____

1 Вашето състояние и целта на процедурата

Околоушната (паротидна) жлеза е най-голямата слюнчена жлеза. Разположена е пред и непосредствено под всяко ухо. През жлезата преминава и се разклонява **лицевият нерв**, който движи мускулите на лицето. Затова операцията на паротидната жлеза е прецизна намеса, при която се обръща специално внимание на запазването на този нерв.

Паротидектомия най-често се извършва поради **образувание (тумор)** в жлезата. По-голямата част от тези образувания (около 80%) са **доброкачествени**; най-чести са плеоморфният аденом и туморът на Уортин. Доброкачествените образувания също могат да нарастват с времето, а някои от тях (особено плеоморфният

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

аденом) с течение на много години могат да се превърнат в злокачествени. По-рядко операция се налага поради повтарящи се възпаления, камъни или злокачествен тумор.

Целта на операцията е образуването или болестно променената тъкан на жлезата да бъдат отстранени напълно, **като се запази лицевият нерв**, и да се постави окончателната диагноза чрез хистологично изследване.

2 Как се извършва процедурата?

Операцията се извършва под обща анестезия в операционна зала. Преди операцията образуването се оценява с ехография, ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) и/или тънкоиглена биопсия; тези изследвания дават полезна предварителна информация, но окончателната диагноза се поставя след операцията чрез хистологично изследване.

1. **Разрез:** Разрезът обикновено започва в естествената гънка пред ухото, заобикаля под ушната висулка и продължава в кожна гънка на шията. При подходящи случаи разрезът може да бъде по-къс или скрит по границата на окосмяването.
2. **Откриване на лицевия нерв:** Кожата и тъканите над жлезата се повдигат и се открива основният ствол на лицевия нерв. Ако се използва, апаратът за **невромониторинг** помага да се проследяват положението и функцията на нерва по време на цялата операция.
3. **Отстраняване на образуването/жлезата:** Като внимателно се проследяват нервът и неговите клончета, образуването се отстранява заедно с ивица здрава жлезна тъкан. В зависимост от разположението и големината му се отстранява само външната част на жлезата (повърхностна), част от нея или цялата жлеза (тотална).
4. **Хистологично изследване:** Отстранената тъкан се изпраща за хистологично изследване. Окончателният резултат обикновено е готов до 1–2 седмици.
5. **Затваряне:** Извършва се контрол на кървенето и обикновено се поставя тънък **дрен** (тръбичка) за извеждане на насъбралата се кръв и течност. Кожата се зашива с фини конци и може да се постави леко компресивна превръзка.

Ако туморът обхваща или е прораснал в лицевия нерв (това се случва най-вече при злокачествени тумори), за пълното му отстраняване може да се наложи да се пожертва клонче или целият нерв. Тази възможност се **обсъжда с вас отделно** преди операцията. Нервът не се прерязва неочаквано без предварително обсъждане с вас; какво ще се направи, ако туморът не може да бъде отделен от нерва, се договаря с вас предварително.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ	ПРЕСТОЙ В БОЛНИЦА / ИЗПИСВАНЕ
Обща анестезия	Около 2–4 часа	Обикновено 1–2 нощи в болница; изписване след премахване на дрена

3 Очаквани ползи и вероятност за успех

- Отстраняване на образуването и поставяне на окончателна диагноза
- Предотвратяване на нарастването на доброкачествено образувание, притискането на лицевия нерв и в дългосрочен план злокачественото му израждане
- При злокачествени тумори — първата и най-важна стъпка от лечението
- Прекратяване на болката и отока, причинени от повтарящи се възпаления или камъни

При повечето доброкачествени тумори операцията води до трайно излекуване. При плеоморфни аденоми, отстранени с подходяща техника, честотата на рецидив е **под 1–2 на 100 пациенти**; разкъсването на капсулата на тумора или предишна операция увеличават тази честота. Туморът на Уортин може да се появи като ново огнище в същата или в другата жлеза. При злокачествените тумори резултатът зависи от вида и стадия на тумора и може да е необходимо допълнително лечение.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

4 Други възможности за лечение

- **Наблюдение:** При някои малки образувания, които се смятат за доброкачествени (например тумор на Уортин при възрастни пациенти или при висок оперативен риск), може да се обсъди редовно проследяване с ехография/ЯМР. В този случай образуването остава на мястото си и може да нарасне, а окончателна диагноза не може да бъде поставена.
- **Медикаментозно лечение:** При възпаления и камъни — антибиотици, обилен прием на течности, масаж; при подходящи случаи отстраняване на камъни чрез ендоскопия на слюнчения канал (сиалендоскопия). При тумори медикаментозното лечение не е алтернатива.
- **Лъчетерапия:** Прилага се при злокачествени тумори, които не могат да бъдат оперирани, или като допълнение към операцията; не е предпочитано лечение при доброкачествени тумори.

5 Какво ще стане, ако процедурата не бъде извършена?

Без операция образуването остава и окончателна диагноза не може да бъде поставена. Доброкачествените тумори обикновено растат бавно, но с времето могат да се уголемят, което затруднява операцията и увеличава риска за лицевия нерв; плеоморфните аденоми с течение на годините могат да се превърнат в злокачествени (около 5–10%). Нелекуваният злокачествен тумор прогресира и може да се разпространи към околните тъкани и лимфните възли.

Имате право да откажете препоръчаната процедура, да я отложите или да потърсите второ лекарско мнение. Това решение по никакъв начин няма да повлияе на другите медицински грижи, които ви се предлагат. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време преди началото на процедурата; трябва обаче да знаете, че след като процедурата започне, може да има етапи, на които прекъсването ѝ би било нежелателно от медицинска гледна точка.

6 Подготовка за процедурата

- Преди операцията се извършват кръвни изследвания, образни изследвания (ехография/ЯМР) и при нужда тънкоиглена биопсия; ще бъдете прегледани от анестезиолог.
- Не трябва да ядете и пиете нищо **6–8 часа** преди операцията (следвайте указанията на анестезиолога).
- При мъжете брадата и космите около ухото в зоната на разреза може да бъдат скъсени в деня на операцията. В зависимост от разреза косата зад ухото може да бъде леко подстригана.
- Движенията на лицето ви се преглеждат и фотографират преди операцията, за да се документира изходното им състояние.
- Съобщете на лекаря си за **всички лекарства**, които приемате (включително средства за разреждане на кръвта, аспирин, обезболяващи, лекарства за отслабване и хормонални препарати), както и за **билкови продукти и хранителни добавки** (омега-3, витамин Е, гинко, чесън, женшен, рибено масло и др.). Не спирайте сами никое лекарство без съвет от лекаря.
- Задължително ни информирайте за **алергии**, проблеми с кървенето или съсирването на кръвта, сърдечни и белодробни заболявания, диабет, високо кръвно налягане, заболявания на щитовидната жлеза, предишни операции и проблеми при предишни анестезии.
- Ако има вероятност да сте бременна или кърмите, кажете ни преди процедурата.
- Тютюнопушенето и никотиновите продукти значително влошават заздравяването на раните. Препоръчително е да ги спрете поне 2–4 седмици преди процедурата и да не пушите по време на възстановяването.

7 Възстановяване: какво да очаквате

Първите 24–48 часа	В оперираната област ще има усещане за опъване, лека до умерена болка и оток, които се овладяват с обезболяващи. Дренът обикновено се премахва на 1–2-ия ден, когато количеството течност намалее. Препоръчва се да спите с повдигната глава. Движенията на лицето ви ще бъдат проверявани.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

1-ва седмица	След изписването можете да се върнете към ежедневните си занимания. Конците обикновено се свалят на **5–7-ия ден**. Изтръпването на ушната висулка и областта пред ухото е изразено. Хистологичният резултат обикновено е готов в този период или малко след това и ще бъде обсъден с вас.
2–6-а седмица	Повечето хора се връщат на офис работа до 1–2 седмици. Тежките физически натоварвания и работа, свързана с навеждане и вдигане, трябва да се отложат за около **2–3 седмици**. Ако има временна слабост на лицевите мускули, тя обикновено започва да се подобрява в рамките на седмици; препоръчват се защита на окото и упражнения за лицето.
3–12-и месец	Белегът постепенно избледнява. Изтръпването на ушната висулка частично намалява. Повечето пациенти с временна слабост на нерва се възстановяват напълно за 6–12 месеца. Изпотяване на бузата при хранене (синдром на Фрей), ако се появи, може да започне в този период.

8 Възможни рискове и усложнения

Както всяка медицинска процедура, и тази носи определени рискове. По-долу **очакваните временни ефекти** и **усложненията** са описани отделно и са групирани според това колко често се срещат. Посочените стойности са **приблизителни** и се основават на медицинската литература; вашият личен риск може да бъде по-нисък или по-висок в зависимост от възрастта, общото здравословно състояние, тютюнопушенето и предишните операции.

По-голямата част от усложненията са **временни** и отзвучават при подходящо лечение. В списъка са включени и много редки, но сериозни състояния; това, че са описани, не означава, че ще се случат при вас, но трябва да знаете за тях, за да вземете информирано решение.

Очаквани временни ефекти (не са усложнения — естествена част от заздравяването)

- Болка, опъване и оток в оперираната област
- Изтръпване на ушната висулка и кожата пред ухото
- Белег на мястото на разреза (избледнява с времето)
- Лека болка от оперираната страна при отваряне на устата или дъвчене (първите дни)

Чести състояния (повечето са временни или отзвучават с лечение)

- **Временна слабост на лицевия нерв** — При около **10–40 от 100** пациенти (в зависимост от обема на отстранената тъкан и разположението на образуването) се появява временна слабост в ъгъла на устата, при затваряне на окото или при повдигане на веждата. Обикновено засяга само едно клонче и **се подобрява в рамките на седмици до месеци**. Ако през това време окото ви не се затваря напълно, ще са необходими капки, гел и превръзка за окото през нощта, за да се предотврати изсъхването му.
- **Трайно намалена чувствителност на ушната висулка** — Нервът, който осигурява чувствителността на ушната висулка (големият ушен нерв), се засяга при повечето операции. При повечето пациенти изтръпването намалява с времето, но известна намалена чувствителност на ушната висулка и околната област може да остане **трайно**. Обикновено това не пречи на ежедневието.
- **Синдром на Фрей (изпотяване при хранене)** — Изпотяване и зачервяване на бузата от оперираната страна по време на хранене. Макар че с тестове се установява по-често, забележим е при около **10–20 от 100** пациенти и обикновено започва месеци по-късно. Ако е неприятен, може да се лекува с кремове против изпотяване или инжекции с **ботулинов токсин**.
- **Хлътване в областта на бузата** — В зависимост от количеството отстранена тъкан може да се получи леко хлътване пред ухото и разлика между двете страни. Ако е забележимо, може да се коригира с мастна тъкан или филър.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Нечести състояния

- **Събиране на течност (серома) или на слюнка (сиалоцеле) / слюнчена фистула** — При около **5–10 от 100** пациенти в оперираната област може да се събере течност или слюнка; рядко тя изтича през кожата (фистула). Обикновено отзвучава до няколко седмици с пункция, компресивна превръзка и при нужда ботулинов токсин.
- **Кървене и хематом** — При около **1–3 от 100** пациенти под кожата може да се събере кръв. Ако хематомът е голям, може да се наложи да бъде отстранен и кървенето да бъде спряно в операционна зала.
- **Инфекция на раната** — Среща се при **1–3 от 100** пациенти; обикновено отзвучава с антибиотици, рядко е необходимо дрениране.
- **Синдром на „първата хапка“** — Особено след операции в дълбокия дял — остра болка в ъгъла на долната челюст, продължаваща няколко секунди при първите хапки от храненето. Обикновено намалява с времето.
- **Рецидив на образуването** — Макар и нечесто при доброкачествените тумори, образуването може да се появи отново в същата област, а при тумор на Уортин може да се развие ново огнище; това може да наложи нова операция. При повторни операции рискът за лицевия нерв е по-висок.
- **Задебелен белег или келоид** — В зависимост от индивидуалната склонност белегът може да задебелее; може да се приложат инжекции с кортикостероид или други методи за лечение на белези.

Редки или много редки, но потенциално сериозни състояния

- **Трайна парализа на лицевия нерв** — При доброкачествени тумори и първа операция при около **1–3 от 100** пациенти може да остане трайна слабост на едно клонче на лицевия нерв или, рядко, на целия нерв. Това може да доведе до увисване на ъгъла на устата, непълно затваряне на окото, асиметрична усмивка и сухота на окото; ако окото не бъде защитено, може да настъпи увреждане на роговицата и загуба на зрение. Рискът е по-висок при злокачествени тумори, повторни операции и образувания, сраснали с нерва. При развитие на трайна парализа може да се наложи допълнително лечение — лекарства за защита на окото, поставяне на тежест в клепача, възстановяване на нерва или операции за възстановяване на движенията на лицето (лицева реанимация).
- **Окончателен хистологичен резултат, различен от предварителната диагноза** — Дори предоперативните изследвания да показват доброкачествено образувание, окончателното хистологично изследване може да установи **злокачествен** тумор. В такъв случай може да е необходима допълнителна операция (отстраняване на останалата част от жлезата или на шийните лимфни възли), лъчетерапия или друго лечение.
- **Голям хематом на шията, засягащ дихателните пътища** — Много рядко бързо нарастващ кръвоизлив може да притисне шията и да затрудни преглъщането или дишането. Това е спешно състояние: хематомът трябва незабавно да бъде отстранен в операционна зала, а рядко се налага осигуряване на дихателните пътища (интубация или трахеостомия).
- **Нарушено кръвоснабдяване на кожата** — Разтваряне на ръба на раната, особено под ушната висулка, поради намалено кръвоснабдяване на кожата; по-често при пушачи.
- **Промяна във формата на ушната висулка или нарушена чувствителност на ушната мида** — Рядко, във връзка с разреза и засягането на нерви.

Общи рискове при всяка хирургична / медицинска намеса

- **Рискове от анестезията:** Ако се използва обща анестезия или седация, рисковете (гадене, болки в гърлото, увреждане на зъб, алергична реакция и много рядко сърдечни или белодробни проблеми) ще ви бъдат обяснени отделно от анестезиолога, а съгласието ви ще бъде взето с **отделен формуляр за анестезия**.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Кървене и кръвопреливане:** Необходимостта от кръвопреливане при тези процедури е много рядка. При сериозно кървене може да се наложи прилагане на кръв или кръвни продукти; те носят собствени много редки рискове (напр. алергия или инфекция).
- **Инфекция:** Инфекцията на раната след операция обикновено се лекува с антибиотици; рядко може да се наложи дрениране (отстраняване на натрупаната гной).
- **Кръвни съсиреци във вените на краката (дълбока венозна тромбоза) и в белите дробове (белодробна емболия):** Много редки при кратки операции в областта на главата и шията. Ранното раздвижване намалява риска. Хормоналните лекарства, тютюнопушенето, затлъстяването и предишни тромбози увеличават риска.
- **Алергия към лекарства:** Може да се развие алергична реакция към използваните лекарства, антисептици, лепенки или конци.
- **Белези и проблеми със заздравяването:** Белезите са различни при различните хора; много рядко може да се образува задебелен (хипертрофичен) белег или келоид.
- **Риск за живота:** Смъртният изход при планови операции в областта на главата и шията днес е изключително рядък; нито една хирургична намеса обаче не е напълно без риск. При сериозно усложнение може да се наложи лечение в интензивно отделение и да остане трайно увреждане.

Този списък не обхваща всички възможни усложнения; могат да възникнат и други непредвидими и много редки състояния. Ако се развие усложнение, лекарят ви ще планира необходимото лечение и проследяване; това може да наложи допълнително лечение, лекарства, процедури или повторна операция.

9 Кога да се свържете с нас незабавно

- **Бързо нарастващ оток на шията или бузата**, особено придружен от затруднено преглъщане или дишане (спешен случай — обадете се на 112)
- **Кървене, което не спира**, от дрена или раната
- **Температура над 38,5 °C**, нарастващо зачервяване, болка, затопляне или гнойна секреция от раната
- **Новопоявила се или засилваща се слабост** в движенията на лицето
- Ако не можете да затворите окото си напълно: **зачервяване, усещане за песъчинки, болка или замъглено зрение**
- **Изтичане на бистра течност** от раната или мека подутина пред ухото, която продължава да расте

Ако се появи някое от тези състояния, обадете се незабавно на лекаря си: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Ако не можете да се свържете с нас, отидете в най-близкото спешно отделение или се обадете на 112.

10 Препоръки относно лекарства и ежедневие

- Не мокрете раната през първите 48 часа; след това можете да вземете кратък хладък душ според указанията.
- През първите седмици избягването на много кисели храни и храни, които силно стимулират слюноотделянето, може да намали риска от събиране на течност.
- Ако имате слабост на лицевия нерв, използвайте изкуствени сълзи през деня, а през нощта — гел за очи и превръзка; пазете окото от вятър и прах.
- Пазете белега от слънце поне 6 месеца (слънцезащитен крем с висок фактор).
- Задължително обсъдете хистологичния резултат и плана за проследяване с лекаря си; редовни контролни прегледи се препоръчват и при доброкачествени тумори.
- Приемайте предписаните ви лекарства (антибиотици, обезболяващи и др.) в препоръчаната доза и за препоръчания срок. Не приемайте аспирин или подобни лекарства, които могат да засилят кървенето, без да се консултирате с лекаря.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- При полет или пътуване по-дълго от 4 часа след операцията пийте достатъчно вода, раздвижвайте се често и при препоръка носете компресивни чорапи; това намалява риска от образуване на кръвни съсиреци в краката.
- По време на възстановяването се препоръчва да не консумирате алкохол и да избягвате тютюнопушене и никотинови продукти.
- Моля, явявайте се на всички контролни прегледи. Ако сте пристигнали от чужбина, проследяването след завръщането ви може да продължи чрез онлайн консултации и снимки/видео; ако се наложи да посетите местен лекар, ще получите писмена епикриза с описание на операцията и нашите препоръки.

11 Непредвидени ситуации по време на процедурата, тъканни проби и кръвни продукти

Ако по време на процедурата възникне непредвидена ситуация, лекарят ще остане в рамките на процедурата, за която сте дали съгласие с този формуляр. **Освен при опасност за живота или риск от сериозно увреждане на орган**, няма да бъде извършена допълнителна процедура, за която не сте дали съгласие; в такъв случай процедурата ще бъде приключена на подходящ етап, ще бъдете информирани след това и решението ще бъде взето заедно с вас. При опасност за живота ще бъде извършена спешната намеса, необходима за опазване на живота или органа ви.

Отстранените по време на процедурата тъкани при необходимост се изпращат за **хистологично (патологично) изследване** за потвърждаване на диагнозата. В зависимост от резултата може да е необходимо допълнително лечение или проследяване.

Кръвопреливане при тези процедури се налага много рядко и се извършва само когато е жизнено необходимо. Ако не приемате кръв или кръвни продукти (например по религиозни причини), задължително ни уведомете преди процедурата; възможните последици от това решение ще бъдат обсъдени с вас отделно и записани в раздел „Информация, специфична за вас“.

12 Снимки, видеозаписи и вашите лични данни

Преди и след процедурата може да бъдат направени **снимки/видеозаписи** с цел планиране, проследяване и оценка на резултата. Тези записи са част от медицинското ви досие и се пазят поверително. Изображенията ви **в никакъв случай няма да бъдат използвани за реклама, промоция или в социалните мрежи.**

Изображенията ви могат да бъдат използвани за други цели **само с вашето отделно и изрично разрешение**. Отказът ви по никакъв начин няма да повлияе на лечението, а даденото разрешение можете да оттеглите по всяко време:

☐ Съгласен/съгласна съм изображенията ми да се използват **само за медицинската документация и проследяване на лечението**.

☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, който не позволява да бъда разпознат/а** (с покрито лице/очи).

☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, по който мога да бъда разпознат/а**.

☐ **Не разрешавам** използване за научни/образователни цели.

Вашите лични и здравни данни се обработват съгласно турския Закон за защита на личните данни № 6698 (KVKK) и приложимото здравно законодателство, за целите на диагностиката, лечението и законовите задължения, от лица, обвързани с професионална тайна. Подробна информация можете да намерите в нашето Уведомление за защита на личните данни.

13 Информация и бележки, специфични за вас (попълва се от лекаря)

Допълнителни рискове, специфични за пациента (придружаващи заболявания, лекарства, предишни операции), подробности за плана, очаквания на пациента, зададени въпроси и дадени отговори. Ако няма какво да се добави, пише се „няма“.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

14 Декларация на пациента

- ☐ Прочетох и разбрах този формуляр на моя език. Беше ми дадено достатъчно време за размисъл; имах възможност да задам въпроси и получих задоволителни отговори.
- ☐ Бяха ми обяснени устно и писмено моето състояние, целта на препоръчаната процедура, как, от кого и къде ще бъде извършена, приблизителната ѝ продължителност, очакваните ползи, вероятността за успех, алтернативите и какво може да се случи, ако не бъде извършена.
- ☐ Бяха ми обяснени честите и потенциално сериозните рискове, както и възможните последици от тези усложнения (включително че може да се наложи допълнително лечение или повторна процедура/операция). Разбирам, че резултатът от никоя медицинска процедура **не може да бъде гарантиран на 100%**.
- ☐ Дадох вярна и пълна информация за здравословното си състояние, лекарствата, които приемам, алергиите и прекараните заболявания. Разбирам, че непълната или невярна информация може да увеличи рисковете.
- ☐ Разбирам, че спазването на указанията преди и след процедурата е част от резултата и че явяването на контролни прегледи е важно.
- ☐ Знам, че мога да оттегля съгласието си по всяко време преди началото на процедурата. Разбирам, че подписването на този формуляр не освобождава лекаря от задължението му да полага дължимата грижа.
- ☐ Вземам това решение по собствена свободна воля, без натиск от когото и да било.
- ☐ Разбирам, че връзката между лицевия нерв и образуването може да бъде видяна със сигурност едва по време на операцията, че окончателната диагноза ще бъде поставена от хистологичното изследване след операцията и че в зависимост от резултата може да е необходимо допълнително лечение.
- ☐ Какво ще се направи с нерва, ако туморът е прораснал в лицевия нерв, беше обсъдено с мен преди операцията и решението ми е отбелязано в раздела с данни за пациента.

- ☐ **ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура.**
- ☐ **НЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура. Бяха ми обяснени възможните последици от отказа.**

Препоръчва се пациентът да напише собственоръчно: „Прочетох и разбрах този формуляр и давам съгласието си.“

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

15 Подписи

	ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ДАТА / ЧАС
Пациент			
Законен представител (родител / настойник) — родство:			
Лекар, предоставил информацията и извършващ процедурата			
Преводач (при нужда) — език:			
Свидетел (при нужда)			

Декларация на преводача: Преведох пълно и точно този формуляр и устните обяснения на лекаря на пациента / законния представител на език, който той/тя разбира.

ЗА ПАЦИЕНТИ ПОД 18 ГОДИНИ ИЛИ С ОГРАНИЧЕНА СПОСОБНОСТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

При пациенти под 18 години съгласието се дава от **родител или настойник**. Детето се информира по начин, съобразен с възрастта и зрелостта му, и се взема предвид неговото мнение. При пациенти с ограничена дееспособност съгласието се дава от законния представител.

☐ Ако упражняваме родителските права съвместно, декларирам, че другият родител е информиран и е съгласен с тази процедура.

☐ Декларирам, че няма съдебно решение или спор относно родителските права / настойничеството (ако има, съответният документ е показан на лекаря).

Детето е информирано по подходящ за възрастта му начин; мнение на детето: _____

Този формуляр е изготвен в два екземпляра: единият се съхранява в досието на пациента, а другият се предоставя на пациента / законния представител.

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО (ПОПЪЛВА СЕ САМО АКО СЕ ОТКАЖЕТЕ)

Оттеглям даденото по-горе съгласие. Бяха ми обяснени възможните последици от оттеглянето.

Име, подпис, дата и час на пациента/представителя, оттеглящ съгласието: _____

Този формуляр е изготвен в съответствие с Наредбата за правата на пациентите на Република Турция и принципите на Турския лекарски съюз за информирано съгласие. Той допълва, но не заменя устното обяснение на вашия лекар.